

Douleur thoracique de l'adulte

Définition

Une douleur thoracique est une sensation désagréable dans la poitrine. Cette douleur peut avoir une origine mettant en jeu le pronostic vital à court terme. C'est pourquoi cette plainte, qui est un des principaux motifs d'appel au SAMU-Centre 15, doit être gérée avec le plus grand intérêt.

Évaluation

Lors d'un appel pour douleur thoracique, le plus important est de discerner les critères de gravité évoquant une pathologie grave ou nécessitant des examens complémentaires en urgence.



La durée de l'entretien initial de l'ARM ne doit idéalement pas dépasser 90 secondes avant le transfert de l'appel au médecin régulateur.



Prendre le patient en ligne dès que possible.

- Rechercher l'atteinte d'une fonction vitale.



Inconscient qui ne respire pas = arrêt cardiaque.



→ Se référer à la prise en charge de l'arrêt cardiaque (voir fiche 11).

Les informations essentielles à recueillir en cas de douleur thoracique sont :

- description qualitative et quantitative de la douleur ; interrogatoire neutre, laisser le patient décrire spontanément sa douleur :
 - circonstances d'apparition : au repos, à l'effort, première fois ou récidive, depuis combien de temps, brutalement ou progressivement,
 - type de douleur : serre, pique, brûle, etc.,
 - siège de la douleur : côté droit ou gauche, devant ou derrière, milieu de la poitrine, sous le sein, barre thoracique,
 - la douleur se déplace-t-elle ? vers où ?
 - irradiation ? vers la mâchoire, l'épaule ou le bras, le dos, le ventre ?

- critères de modification de la douleur :
 - modifiée à la respiration,
 - modifiée par la mobilisation ou une certaine position,
 - douleur reproduite à la palpation ;
- recherche des facteurs de risque cardiovasculaires :
 - âge supérieur à 55 ans,
 - tabagisme actif ou tabagisme important sevré,
 - diabète,
 - hypertension artérielle,
 - surpoids,
 - antécédents personnels de coronaropathie (infarctus, angine de poitrine, pose de stents),
 - antécédents familiaux de coronaropathie avant l'âge de 60 ans ;
- signes associés à la douleur :
 - fièvre,
 - gêne respiratoire, toux,
 - sueurs, sensation de malaise,
 - douleurs associées (membres inférieurs),
 - signes neurologiques : troubles de la conscience, déficit neurologique localisé.

Dans tous les cas, une douleur thoracique de l'adulte doit être régulée par un médecin, car l'interrogatoire est primordial pour décider de la suite de la prise en charge.



Messages pour l'appelant

En attendant la régulation médicale ou l'arrivée des secours :

- **aucun effort, mise au repos immédiate ;**
- **ne pas boire, ni manger, ni fumer ;**
- **faire préparer le dossier médical (ordonnances, électrocardiogramme [ECG] de référence, comptes rendus d'hospitalisation) ;**
- **si gêne respiratoire associée : position demi-assise ;**
- **si sensation de malaise, possible perte de connaissance : position allongée, jambes surélevées ;**
- **si plusieurs témoins : faciliter l'arrivée des secours (ouverture des portes et portails, guidage).**

DOULEUR THORACIQUE

- Description de la douleur : type de douleur, localisation et irradiation, caractère positionnel, modification à la respiration ou la mobilisation
- FDRCV : âge >55 ans, tabagisme, diabète, cholestérol, hypertension artérielle, surpoids, antécédent d'infarctus
- Autres symptômes : sensation de malaise, sueurs, gêne respiratoire, douleur de membre inférieur, signe neurologique, nausées

Douleur thoracique qui serre
(en étau)
+
FDRCV présents
ou irradiation mâchoire/bras
ou malaise/sueurs
=
suspicion d'infarctus du myocarde

Douleur thoracique brutale
et migratrice
+
FDRCV présents
ou signes neurologiques
ou malaise/sueurs
=
suspicion de dissection aortique

Douleur thoracique augmentée sur
le dos et diminuée penché en avant
+
FDRCV absents
et syndrome grippal/rhume récent
=
suspicion de péricardite

Douleur thoracique
mal définie
+
signes respiratoires
ou phlébite
=
suspicion d'embolie pulmonaire

Douleur thoracique augmentée
à l'inspiration et à la mobilisation
+
sujet tabagique grand et mince
et gêne respiratoire
=
suspicion de pneumothorax

Tous les appels pour douleur thoracique de l'adulte doivent être transmis
au médecin régulateur urgentiste

Les appels évocateurs d'infarctus du myocarde et de dissection aortique
doivent être transmis de manière prioritaire

Si au terme de l'interrogatoire ARM, aucun des 5 grands tableaux
n'est évoqué, l'appel est transmis au médecin régulateur urgentiste
pour poursuite de l'interrogatoire

Figure 10.1. Arbre décisionnel : appel pour une douleur thoracique.



Pour aller plus loin

Les cinq causes de douleur thoracique à rechercher : 2PIED

2PIED de la douleur thoracique :

- **P**éricardite;
- **P**neumothorax;
- **I**nfarctus du myocarde;
- **E**mbolie pulmonaire;
- **D**issection aortique.

Péricardite

Il s'agit d'un épanchement de liquide autour du cœur (entre les deux feuillets du péricarde). S'il y a trop de liquide, les cavités cardiaques peuvent être comprimées et le cœur peut ne plus réussir à jouer son rôle de pompe.

Les critères de douleur thoracique évoquant une péricardite sont les suivants :

- notion de syndrome grippal ou rhume dans les jours ou semaines précédant la douleur;
- douleur sourde, milieu de poitrine, sans irradiation;
- douleur augmentée quand la personne est allongée sur le dos;
- douleur diminuée quand la personne se penche en avant;
- possible gêne respiratoire associée, notamment à l'effort.

Pneumothorax

Il s'agit d'un épanchement d'air autour du poumon (entre les deux feuillets de la plèvre). L'air qui s'accumule comprime de plus en plus le poumon qui ne peut plus jouer son rôle d'oxygénation. Tant que le deuxième poumon continue à fonctionner normalement, l'oxygénation est conservée; cependant, il est nécessaire de traiter le pneumothorax rapidement pour éviter un pneumothorax bilatéral ou compressif (pression d'air dans la plèvre telle que le poumon, mais également les vaisseaux sanguins et les voies respiratoires peuvent être altérés).

Les critères de pneumothorax sont les suivants :

- douleur facilement localisable, potentiellement de début brutal;
- chez un individu généralement grand et maigre;
- le tabagisme est un facteur de risque;
- douleur de type mécanique : augmentée à l'inspiration profonde et parfois à la mobilisation.

Infarctus du myocarde

C'est, dans le langage courant, la crise cardiaque. Il s'agit de l'occlusion d'une artère coronaire, notamment par de l'athérome (dépôts sur les parois des artères de résidus dont la formation est favorisée par le diabète, le tabac, le cholestérol, l'hypertension artérielle, l'âge). Toute la zone de myocarde vascularisée par l'artère bouchée en aval de l'obstacle ne reçoit plus de sang et donc plus d'oxygène et souffre. Il faut déboucher l'artère en urgence pour rétablir l'oxygénation du muscle cardiaque. C'est une urgence vitale.

Les critères évocateurs d'infarctus du myocarde sont les suivants :

- présence de FDRCV : âge supérieur à 55 ans, tabagisme, diabète, cholestérol, hypertension artérielle, surpoids, antécédent d'infarctus;
- douleur à type de poids dans la poitrine, qui serre comme un étau, irradiant classiquement dans la mâchoire et le bras gauche (sensation d'engourdissement);
- sensation de malaise, sueurs associées;
- attention : il existe des tableaux cliniques pouvant prêter à confusion (douleur à l'estomac avec nausées de l'infarctus inférieur par exemple, ou encore absence de douleur chez le patient diabétique).

Il faut donc évoquer l'infarctus devant un faisceau d'arguments, même si la douleur n'est pas typique.

Embolie pulmonaire

Il s'agit de l'occlusion des vaisseaux pulmonaires par des caillots. Le plus souvent, ces caillots proviennent de la stase sanguine dans les veines des membres inférieurs (phlébite provoquant une embolie pulmonaire) ou de la formation d'un caillot lié à un cancer évolutif. Si les vaisseaux pulmonaires sont bouchés, le sang ne peut plus être éjecté vers les poumons; ne pouvant plus être oxygéné ni aller dans les cavités gauches du cœur, il en résulte des complications respiratoires et circulatoires.

Les critères évocateurs d'embolie pulmonaire sont les suivants :

- douleur thoracique ou gêne thoracique sans particularité dans la description;
- gêne respiratoire (dyspnée), fatigue;
- la présence d'une phlébite (jambe gonflée, rouge, chaude, douloureuse) et d'une gêne respiratoire ou d'une douleur thoracique impose d'éliminer une embolie pulmonaire.

Dissection aortique

Il s'agit de la déchirure de la paroi de l'aorte (la plus grosse artère du corps humain), créant ainsi un faux chenal, c'est-à-dire un cul-de-sac dans lequel le sang s'engouffre. Ainsi, une partie du sang continue de vasculariser le corps, mais toutes les artères en regard de la paroi disséquée ne sont plus vascularisées et les organes en aval ne sont plus oxygénés. Il faut donc rétablir la circulation sanguine au plus vite. C'est une urgence vitale.

Éléments évocateurs de dissection aortique :

- FDRCV : âge supérieur à 55 ans, tabagisme, diabète, cholestérol, hypertension artérielle, surpoids, antécédent d'infarctus;
- douleur dorsale, brutale, en coup de poignard, migratrice (descendante ou ascendante avec irradiation thoracique);
- sensation forte de malaise, sueurs profuses;
- si association de douleur thoracique ou dorsale et de signes neurologiques (trouble de la conscience, trouble de la parole, difficulté à mobiliser un bras, vertige vrai), il faut évoquer une dissection aortique avec dissection de l'artère carotide.

**Abréviations et termes utilisés en régulation***Abréviations*

- ECG : électrocardiogramme.
- FDRCV : facteur de risque cardiovasculaire.

Termes

- Coronaropathie : maladie des artères coronaires.
- Stent : dispositif médical inséré dans une artère pour la maintenir perméable.